

Consent Information - Patient Copy
Upper Gastrointestinal
Endoscopy for Bleeding

معلومات الإقرار - نسخة المريض
التنظير العلوي للجهاز الهضمي (المعدة والأمعاء) عند وجود نزيف

1. What is an upper gastrointestinal endoscopy for bleeding?

An upper gastrointestinal (GI) endoscopy is where the doctor uses an instrument called an endoscope to look at the inside lining of your oesophagus (food pipe), stomach and duodenum (first part of the small intestine). This is being done to look for the reason for the bleeding you are having and to try to do some treatment to stop the bleeding if it seems unlikely it is going to stop by itself.

The treatment depends on the cause of the bleeding and could include;

- an injection of adrenaline or
- the burning of a bleeding blood vessel with a special type of probe or
- the placement of a metal clip on a bleeding blood vessel or
- placing rubber bands on a bleeding vein or
- injecting glue into a bleeding vein.

An endoscope is a long, thin, flexible tube with a small camera and light attached which allows the doctor to see the pictures of the inside of your gut on a video screen. The scope bends, so that the doctor can move it around the curves of your gut. The scope also blows air into your stomach; this expands the folds of tissue in your stomach so that the doctor sees the stomach lining better. As a result, you might feel some pressure, bloating or cramping during the procedure.

This instrument can also be used to remove or burn growths or to take tissue biopsies.

You will then lie on your left side, and the doctor will pass the endoscope into your mouth and down your oesophagus (food pipe), stomach and duodenum (first part of the small intestine). Your doctor will examine the lining again as the endoscope is taken out. The endoscope does not cause problems with your breathing.

You should plan on 2 to 3 hours for waiting, preparation and recovery. The procedure itself usually takes anywhere from 10 to 15 minutes.

If the doctor sees anything unusual or want to test for bacteria in the stomach they may need to take a biopsy (small pieces of tissue) for testing at Pathology. This procedure may or may not require a sedation anaesthetic.

2. Will there be any discomfort? Is any anaesthetic needed?

The procedure can be uncomfortable and to make the procedure more comfortable a sedative injection or a light anaesthetic can be given.

If you prefer, it can be done without sedation. Before the procedure begins the doctor;

- will put a drip into a vein in your hand or forearm. This

1. ما هو التنظير العلوي للجهاز الهضمي (المعدة والأمعاء) عند وجود نزيف؟

تنظير الجهاز الهضمي العلوي هو الإجراء الذي يستخدم فيه الطبيب معدة (آلة) تسمى منظار لرؤية الطبقة الداخلية المبطنه للمريء ، المعدة و الاثنى عشر (الجز الأول من الأمعاء الدقيقة). الهدف من هذا الإجراء هو معرفة أسباب النزيف الذي تعاني منه ، و محاولة القيام بمعالجة لإيقاف النزيف إذا كان النزيف على الأرجح لن يتوقف من تلقاء نفسه.

تتوقف المعالجة على أسباب النزيف ، وقد تشمل:

- الحقن بالأدرينالين أو
- حرق (كي) الوعاء الدموي النازف باستخدام مسبار خاص أو
- وضع مشبك معدني على الوعاء الدموي النازف أو
- وضع شريط مطاطي حول على الوريد النزف أو
- حقن صمغ في الوريد النازف.

المنظار عبارة عن أنبوب طويل ، رفيع و مرن به كاميرا صغيرة ومصدر للضوء يمكن الطبيب من رؤية صور لداخل أمعائك على شاشة فيديو .

المنظار قادر على الالتواء مما يمكن الطبيب من تحريكه حول انحناءات الأمعاء. يقوم المنظار أيضاً بضخ الهواء داخل معدتك مما يؤدي إلى فرد (توسعة) طيات الأنسجة داخل المعدة ويعطي الطبيب رؤية أوضح للطبقة المبطنه للمعدة. بسبب ذلك ، قد تشعر ببعض الضغط ، الانتفاخ أو المغص أثناء الإجراء. يمكن للمنظار أيضاً أن يستخدم في إزالة أو حرق (كي) الزوائد التي تنمو ، وكذلك أخذ عينة للأنسجة.

سيطلب منك الاستلقاء على جانبك الأيسر ، وسيقوم الطبيب بتمرير المنظار عبر فمك نزولاً إلى المريء ، المعدة و الجزء الأول من أمعائك (الاثنى عشر). وبينما يتم إخراج المنظار ، يقوم الطبيب بأخذ نظرة أخرى على الطبقة المبطنه. لا يسبب المنظار ولا الآلة الموسعة أي مشاكل متعلقة بالتنفس.

استعد لقضاء 2-3 ساعة للقيام بكامل مراحل هذا الإجراء من انتظار وتحضير وتعافي . الإجراء بحد ذاته يستغرق 10-15 دقيقة.

إذا لاحظ الطبيب أمر غير معتاد أو رغب في إجراء اختبار لوجود بكتيريا في المعدة ، فقد يأخذ خزعة أو عينة للأنسجة (أجزاء صغيرة جداً) لكي يتم اختبارها في مختبر علم الأمراض.

هذا الإجراء قد ، أو قد لا يتطلب تخدير بواسطة دواء مسكن.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟
هذا الإجراء قد لا يكون مريحاً ، ولجعله مريحاً قد يتم إعطائك حقنة مسكنة (مخدر خفيف). وإذا لم تكن تقضل ذلك ، فيمكن

إجراء الفحص دون التخدير. قبل بداية الإجراء :

- يقوم الطبيب بتركيب خط وريدي لك في اليد أو الساعد و يوصله بمحقنة. يتم حقن المسكن أو الدواء المخدر عن طريق هذا الخط الوريدي.
- قد يقوم الطبيب برش حلقك برذاذ (بخاخ) لمادة مخدرة لتفادي حدوث

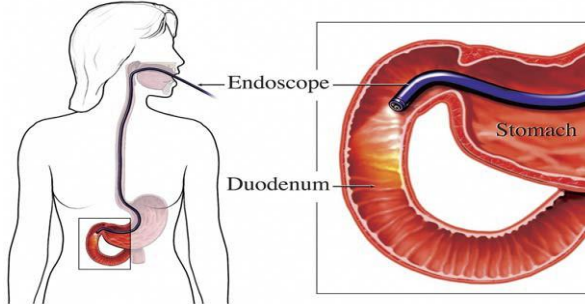
Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

is where the sedation or anaesthetic is injected and

- May spray your throat with a numbing agent that will help prevent gagging.



3. What is sedation?

Sedation is the use of drugs that give you a 'sleepy-like' feeling. It makes you feel very relaxed during a procedure that may be otherwise unpleasant or painful.

You may remember some or little about what has occurred during the procedure.

Anaesthesia is generally very safe but every anaesthetic has a risk of side effects and complications. Whilst these are usually temporary, some of them may cause long-term problems.

The risk to you will depend on:

- personal factors, such as whether you smoke or are overweight.
- whether you have any other illness such as asthma, diabetes, heart disease, kidney disease, high blood pressure or other serious medical conditions.

4. What are the risks of this specific procedure +/- sedation?

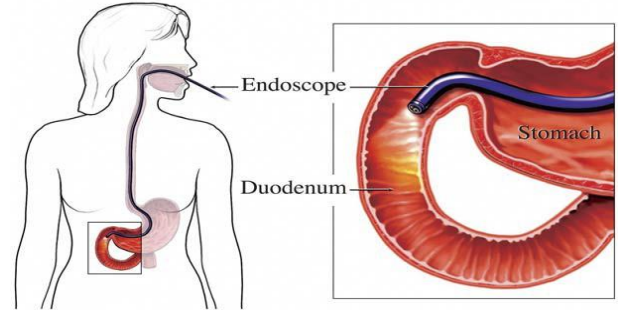
There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Nausea and vomiting.
- Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Headache.
- Pain, redness or bruising at the sedation injection site (usually in the hand or arm).

Notes to talk to my doctor about:

انتقباض للجدار الخلفي للحلق عند ملامسة المنظار له.



3. ماذا يعني التسكين (إعطاء دواء مسكن)؟

هو إعطاء دواء يعطيك شعور بالنوم ويجعلك مسترخ جداً خلال الإجراء ، حيث أن القيام بهذا الإجراء دون إعطاء مسكن قد يكون مزعج ومؤلم.

قد تكون لديك القدرة لتذكر بعض مما حدث أثناء القيام بالإجراء.

التخدير بشكل عام آمن ، إلا أن كل دواء مخدر له مخاطره وآثاره الجانبية و مضاعفاته ، وعلى الرغم أن غالبيتها تكون مؤقتة ، إلا أن البعض منها قد تكون له مشاكل طويلة الأمد.

المخاطر بالنسبة لك تتوقف على:

- عوامل شخصية مثل التدخين أو زيادة الوزن.
- إذا كنت مصاب بأمراض أخرى كالربو الشعبي ، السكري ، مرض في القلب ، مرض في الكلى ، ارتفاع في ضغط الدم أو أي مشكلة طبية أخرى خطيرة.

4. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد +/- التخدير بالمسكن؟
لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- غثيان واستفراغ.
- إغماء أو دوخة خاصة بعد البدء في ممارسة الحركة.
- صداع.
- ألم ، احمرار أو كدمة في موضع حقن المخدر (في اليد أو الذراع).

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
